

Aspects communicationnels avec le malade et sa famille et examen mental

Pr. AMANI M. A.

Professeur en Psychiatrie

Objectifs du cours

- Comprendre les principes de base de l'examen psychiatrique.
- Connaître les différentes étapes de l'examen clinique en psychiatrie.
- Connaître les outils diagnostiques spécifiques.
- Développer des compétences de communication avec le patient et sa famille.

Psychiatrie ?

Qu'est ce que la psychiatrie ?

- La psychiatrie est une **spécialité médicale** traitant les **troubles mentaux**.
- Le mot psychiatrie provient du mot grec psyche qui signifie **âme ou esprit**, et iatros qui signifie **médecin** (littéralement médecine de l'âme).
- Le rôle de la psychiatrie est le **diagnostic**, le **traitement** et la **prévention des troubles mentaux**.

Santé mentale ?

Définition de la santé mentale selon l'OMS

« **état de bien-être** dans lequel l'individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie, et est capable de contribuer à sa communauté »

Il y a 3 dimensions à la santé mentale

- La **santé mentale positive** (épanouissement personnel).
- La **détresse psychologique réactionnelle** (induite par les situations éprouvantes et difficultés existentielles).
- Les **troubles psychiatriques** de durée variable et plus ou moins sévères et/ou handicapants.

Le trouble mentale ?

Le trouble mentale

- Le trouble mental est un **trouble psychologique** ou **comportemental**,
- généralement associé à une **détresse** ou un **handicap**, mais qui peut dans certains cas n'entraîner de détresse que dans l'**entourage** de l'individu atteint d'un trouble mental spécifique,
- il est liée à des altérations **biologiques**, **psychologiques**, **génétiques** ou **sociales**.

Trois grandes catégories de troubles mentaux

- **Psychoses : troubles psychotiques.**
- **Névroses : troubles anxieux et troubles de l'humeur.**
- **Troubles mentaux organiques.**

Psychose ?

Définition de la psychose

- **Perte de contact avec la réalité** chez le sujet.
- Il est notamment utilisé pour caractériser des troubles mentaux durant lesquels des **délires**, **hallucinations** ou des **illusions** peuvent apparaître.
- La psychose peut être accompagnée de **comportements inhabituels** voire **étranges**, et de difficultés d'intégration sociale ou de maintien d'une qualité de vie quotidienne.

Délire ?

Le délire

- **Croyance fausse** avec **conviction inébranlable** en sa réalité, malgré le **désaccord de l'entourage** et l'**absence de confirmation** dans la réalité.

Thèmes répandus de délires

- Délire de persécution
- Délire mégalomaniac (de grandeur)
- Érotomanie
- Délire hypocondriaque
- Délire de jalousie
- Délire de filiation

Mécanismes du délire

- **Hallucination** : perception sans objet, hallucinations auditives (la personne entend des sons, des voix), hallucinations visuelles (le patient voit des choses qui n'existent pas), hallucinations olfactives et gustatives, hallucinations tactiles, hallucinations cénesthésiques.
- **Illusion** : perception déformée
- **Interprétation** : le patient va interpréter de façon erronée les signes, les gestes et les paroles des autres.
- **Imagination**
- **Intuition**

Troubles de l'humeur

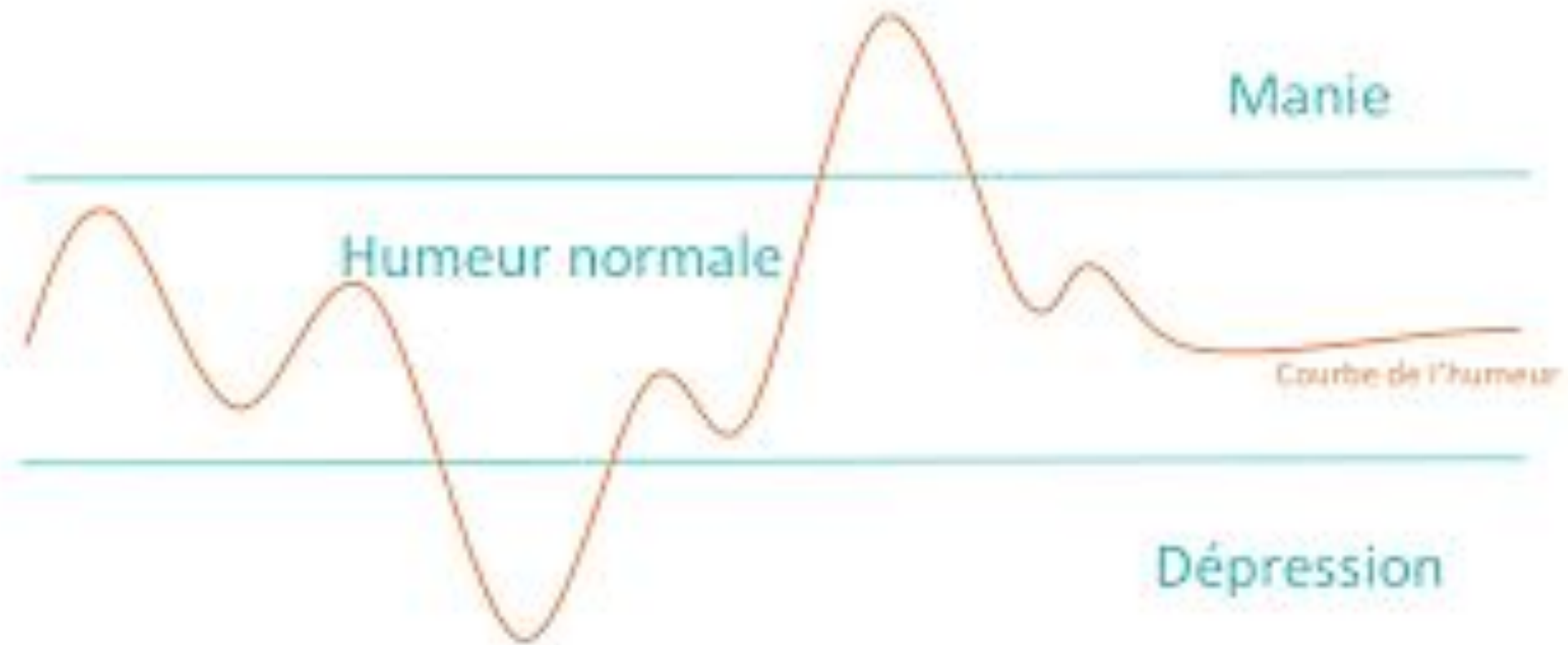
L'humeur

- Disposition affective de base qui varie entre une **tonalité agréable** (pôle du plaisir) et une **tonalité désagréable** (pôle de la douleur).

Mood Tracker



Troubles de l'humeur



Troubles anxieux

Troubles anxieux

- Peur pathologique

LES MODELES EN PSYCHIATRIE

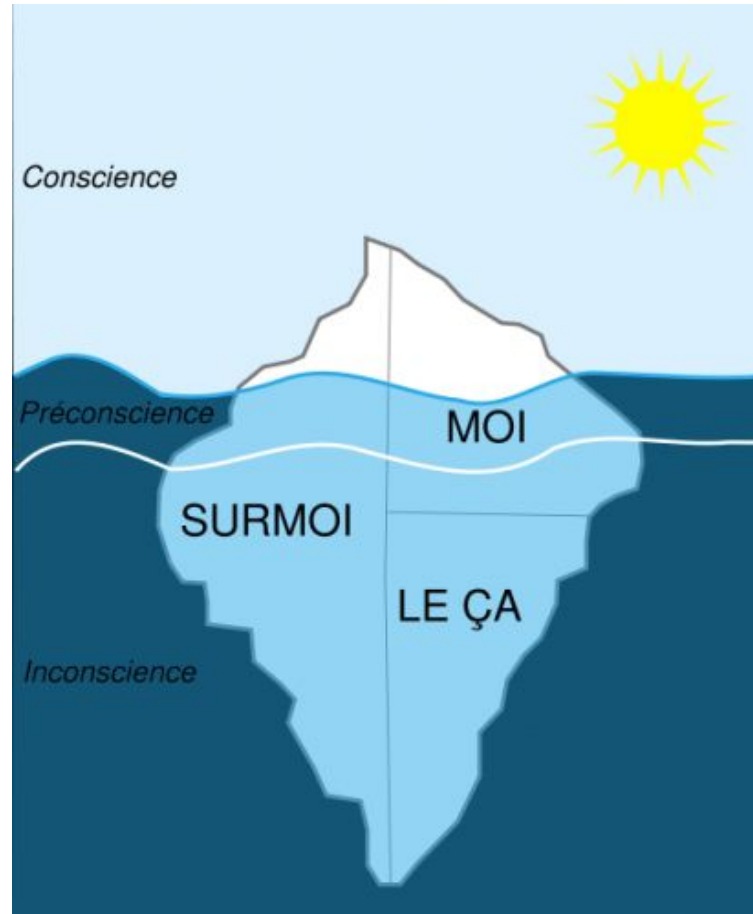
LES MODELES EN PSYCHIATRIE

- Théories étiopathogéniques expliquant le développement des troubles mentaux.

Les modèles biologiques

- **Les modèles pharmacologiques et neurobiochimiques**
- **Le modèle génétique**

Les modèles psycho dynamiques



Le coran

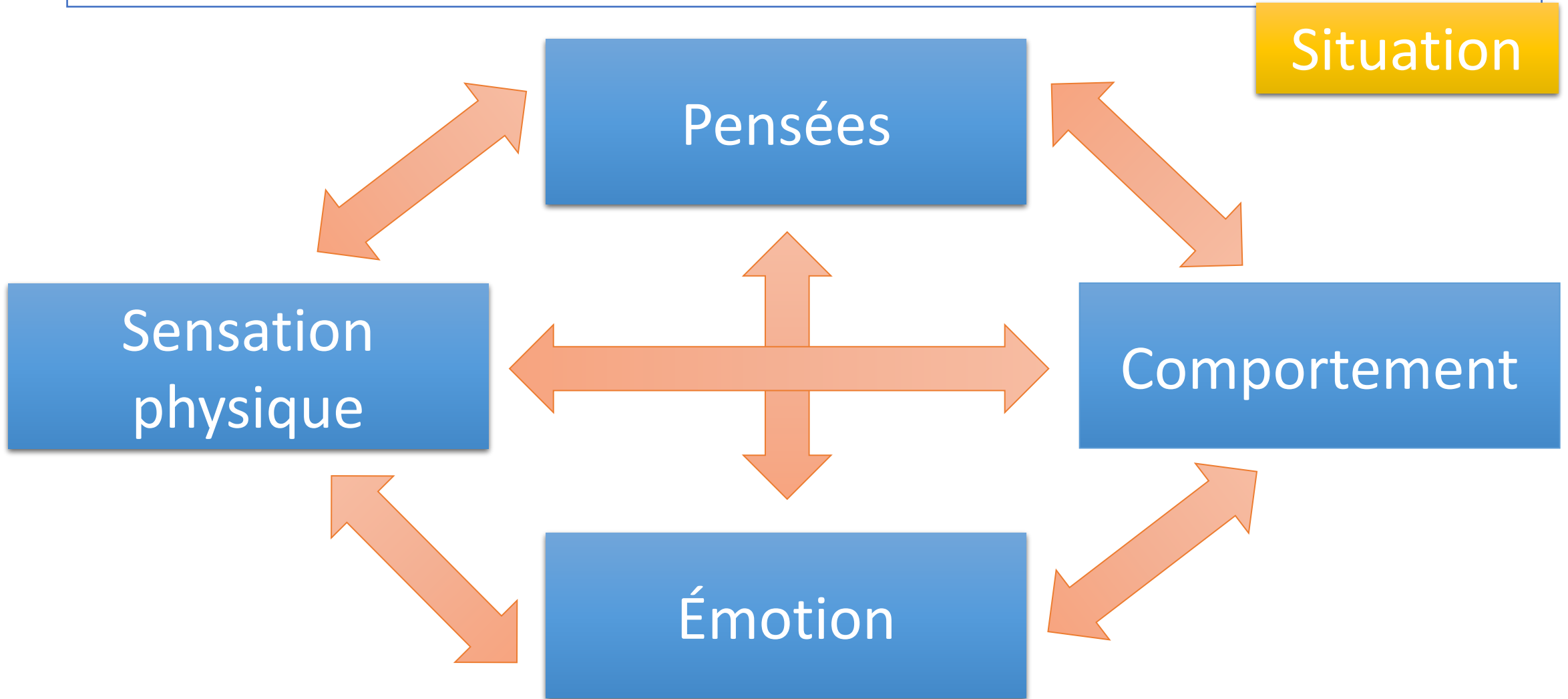
• نفس شريرة: وهي الأمانة بالسوء.

• ونفس خيرة: وهي المطمئنة تأمر بالخير.

• ونفس لوامة.

• { يوسف: 53 }. { الفجر: 28-30 }. { القيامة: 1-2 }.

Modèle cognitivo-comportemental



Les modèles systémiques

- **Proposent d'appréhender les symptômes comme le produit des interférences multiples entre le sujet, son environnement social (écosystème), ses relations avec autrui et notamment l'environnement familial considéré dans sa globalité comme un système.**

Les modèles culturels et sociaux

- **Le rôle des facteurs culturels et sociaux dans le déterminisme et les modes d'expression des troubles mentaux est incontestable et établi par de multiples travaux.**

LES MODELES EN PSYCHIATRIE

- **Origine multifactorielle** et est liées à des altérations biologiques, psychologiques, génétiques et sociales.

Classification

Classification des maladies mentales

- CIM-10
- DSM 5

Classification des maladies mentales

- **DSM 5** : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (APA)
- **CIM-10**: classification internationale des maladies, 10e édition (OMS)

DSM 5 (1)

❖ **LES TROUBLES NEURODEVELOPPEMENTAUX**

❖ **SPECTRE DE LA SCHIZOPHRENIE ET AUTRES TROUBLES**

❖ **TROUBLES BIPOLAIRES ET APPARENTES**

❖ **TROUBLES DEPRESSIFS**

DSM 5 (2)

❖ **TROUBLES ANXIEUX**

❖ **TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS ET APPARENTES**

❖ **TROUBLES LIES A DES TRAUMATISMES OU FACTEURS DE STRESS**

❖ **TROUBLES DISSOCIATIFS**

DSM 5 (3)

- ❖ TROUBLES A SYMPTOMATOLOGIE SOMATIQUE ET APPARENTES
- ❖ TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES ET DE L'INGESTION D'ALIMENTS
- ❖ TROUBLES DU CONTROLE SPHINCTERIEN
- ❖ TROUBLES DE L'ALTERNANCE VEILLE SOMMEIL
- ❖ DYSFONCTIONS SEXUELLES

DSM 5 (4)

- ❖ **DYSPHORIE DE GENRE**
- ❖ **TROUBLES DISRUPTIFS, DU CONTROLE DES IMPULSIONS ET DES CONDUITES**
- ❖ **TROUBLES LIES A UNE SUBSTANCE, TROUBLES ADDICTIFS**
- ❖ **TROUBLES NEUROCOGNITIFS**
- ❖ **TROUBLES DE LA PERSONNALITE**
- ❖ **TROUBLES PARAPHILIQUES**
- ❖ **AUTRES TROUBLES MENTAUX**

Examen psychiatrique

Introduction à l'examen psychiatrique

- Méthode clinique utilisée pour évaluer l'état mental d'un patient, repérer les signes et symptômes psychiatriques et identifier les troubles psychiatriques éventuels.
- Cet examen comprend une étude longitudinale de l'histoire du patient et de sa maladie, ainsi qu'une analyse transversale de son état mental actuel.
- Évaluer non seulement les symptômes présentés par le patient, mais aussi son contexte personnel, social et médical.

Introduction à l'examen psychiatrique

- Lieu de l'examen psychiatrique : hôpital, dispensaire ou cabinet libéral.
- Émotions intenses : angoisse et l'inquiétude
- Le médecin se doit de prendre en compte ses émotions

Introduction à l'examen psychiatrique

- La demande de consultation psychiatrique

Les différentes étapes de l'examen psychiatrique

Les différentes étapes de l'examen psychiatrique

1. Accueil du Patient - Motif de Consultation ou d'Hospitalisation
2. Antécédents
3. Biographie
4. Histoire des troubles
5. Examen mental
6. Examen Somatique
7. Les tests psychométriques et les échelles d'évaluation
8. Regroupement Syndromique
9. Discussion Diagnostique
10. Prise en Charge

Accueil du Patient

- Importance d'un environnement rassurant.
- Présentation et explication du déroulement de l'examen.

Motif de Consultation ou d'Hospitalisation

- Description des symptômes ou des préoccupations (agitation, anxiété, anorexie, comportement bizarre etc.
- Durée et évolution des symptômes.
- Effets sur la vie quotidienne, les relations, le travail.

Antécédents

- **A. Antécédents Familiaux :**

- Consanguinité des parents.
- Parents vivants.
- Antécédents psychiatriques dans la famille.
- Antécédents de maladies somatiques pertinentes.

- **B. Antécédents Personnels :**

- Antécédents médicaux (hospitalisations, traitements).
- Comitialité et traumatisme crânien.
- Prise de toxiques (drogues).
- Antécédents judiciaires.
- Antécédents psychiatriques.

Biographie

- Enfance et scolarité.
- Vie socio affective.
- Vie socio professionnelle.
- Événements de vie significatifs (mariage, décès, perte d'emploi).

Histoire des troubles

- Début des troubles et épisodes antérieurs
- Modalité d'apparition : progressive ou brutale
- Symptômes initiaux : insomnie, isolement, anxiété,
- Facteurs déclenchant : facteurs de stress, traumatisme psychique, maladie organique, aucun.
- Traitements mis en œuvre
- Évolution
- Épisode actuel

Examen mental

Apparence

- Hygiène et soins personnels
- Mimique
- Posture

Affect et humeur

- Déprimé
- Euphorique
- Anxieux

Pensée

- Forme de la pensée : Cohérence, logique, et organisation des idées.
- Contenu de la pensée : Évaluation des thèmes récurrents (idées délirantes, obsessions).

Perception

- Hallucinations
- Illusions

Cognitif

- **Orientation** : Évaluation de la conscience du temps, de la place et de l'identité.
- **Attention** : Tests de concentration (répétition de chiffres, distraction).
- **Mémoire** : Évaluation de la mémoire à court et à long terme (rappel d'événements récents, mémorisation de mots).
- **Fonctions exécutives** : Évaluation de la capacité à planifier, organiser et résoudre des problèmes.

Insight et jugement

- **Insight** : Capacité du patient à reconnaître sa maladie et son impact sur sa vie.
- **Jugement** : Évaluation des décisions prises par le patient et leur pertinence dans des situations données.

Sphère instinctuelles

- Sommeil
- Alimentation
- Sexualité

Examen Somatique

- **A. Évaluation Physique**

- Examen physique général.
- Recherches de signes somatiques associés à des troubles psychiatriques.

- **B. Analyses Complémentaires**

- Tests sanguins, examens d'imagerie si nécessaire.

Les tests psychométriques et les échelles d'évaluation

- Outils d'évaluation ou de diagnostic
- Échelle de dépression de Hamilton
- Échelle d'anxiété de Hamilton
- PANSS
- MMSE

Regroupement Syndromique

Le syndrome dépressif

- Symptômes émotionnels : humeur dépressive, anhédonie et irritabilité
- Symptômes cognitifs : dévalorisation, culpabilité et idées de mort
- Symptômes comportementaux : retrait social, diminution de l'activité
- Symptômes physiques (somatiques) : fatigue, algies, sommeil, appétit
- Symptômes de ralentissement ou d'agitation psychomotrice
- Altération du fonctionnement quotidien

Le syndrome anxieux

- Symptômes émotionnels : inquiétude excessive, peurs irrationnels
- Symptômes cognitifs : ruminations, concentration, indécision
- Symptômes physiques : tachycardie, respiration, tension, transpiration, troubles digestifs et fatigue
- Symptômes comportementaux : évitement, agitation
- Troubles du sommeil

Le syndrome psychotique

- Hallucinations
- Délire
- Discours et comportement désorganisés
- Symptômes négatifs : retrait, isolement, ...
- Troubles cognitifs
- Affect inapproprié ou émoussé

La communication avec le patient et sa famille

Écoute active

- Il s'agit de prêter une attention sincère et sans jugement aux paroles du patient, en restant pleinement concentré sur ce qu'il dit.
- Cela implique des réponses verbales et non verbales montrant que l'on comprend et s'intéresse à ses préoccupations.

Empathie

- Se mettre à la place du patient et essayer de comprendre ses émotions et son point de vue sans pour autant se laisser submerger.
- L'empathie crée une connexion émotionnelle essentielle pour apaiser le patient et favoriser une communication ouverte.

Clarté et simplicité

- Utiliser un langage clair et adapté au niveau de compréhension du patient. Il est important d'éviter le jargon médical complexe, tout en expliquant les informations de manière accessible.

Respect et non-jugement

- Traiter le patient avec dignité, respectant ses opinions et ses choix, même s'ils diffèrent de ceux du professionnel de santé.
- Ne jamais porter de jugement sur son comportement, ses croyances ou ses émotions.

Authenticité

- Être sincère et transparent dans les échanges.
- Un comportement authentique et honnête permet de renforcer la confiance entre le patient et le médecin.

Adaptation à l'état émotionnel du patient

- La communication doit tenir compte de l'état émotionnel et psychologique du patient.
- Par exemple, un patient anxieux ou dépressif nécessite une approche plus douce et rassurante, tandis qu'un patient en crise psychotique peut avoir besoin d'une communication plus structurée.

Réassurance

- Rassurer le patient sur le fait qu'il est compris et que ses préoccupations sont légitimes.
- Exprimer que des solutions ou des options de traitement sont disponibles peut contribuer à diminuer son stress ou son anxiété.

Confidentialité

- Garantir que les informations échangées restent confidentielles est essentiel pour instaurer un climat de sécurité et encourager le patient à se confier sans crainte.

Soutien non-verbal

- Le langage corporel, comme le contact visuel, la posture ouverte, ou les signes d'approbation (hochement de tête), renforce le message verbal et montre au patient qu'il est pris en compte.

Facebook : Santé mentale avec Pr. Amani

Conclusion

Conclusion

- En conclusion, l'examen psychiatrique constitue une étape clé pour comprendre les troubles mentaux du patient, poser un diagnostic précis et établir un plan de traitement adapté.
- Il s'appuie sur une évaluation globale des antécédents, une exploration des symptômes actuels, un examen mental approfondi et l'utilisation d'échelles d'évaluation pour objectiver les symptômes.
- La qualité de la communication entre le soignant et le patient est fondamentale pour le succès de cet examen.

Merci pour votre attention